PRAKTIKUM PERTEMUAN 1
IDENTIFIKASI STAKEHOLDER DAN KONTEKS ORGANISASI

Analisis Stakeholder dan Power–Interest Grid
pada Implementasi Sistem Informasi Klinik
Studi Kasus: Klinik Sehat Bersama

Mata Kuliah : Prak. Analisis & Perencanaan Sistem Informasi
Dosen Pengampu : Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom, M.Kom.

Disusun oleh:

Maulana Wahyudi : 2507072
Dede Risman : 2507059

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Dasar Analisis 1
BAB II PROFIL KASUS 3
2.1 Profil Singkat Organisasi 3
2.2 Proses Kerja Utama 3
2.3 Masalah dan Rencana Sistem 3
2.4 Kondisi dan Kendala Proyek 3
BAB III IDENTIFIKASI STAKEHOLDER 4
3.1 Daftar Stakeholder, Peran, dan Kepentingan 4
3.2 Informasi yang Perlu Digali dari Setiap Stakeholder 5
BAB IV PENILAIAN POWER DAN INTEREST 6
4.1 Hasil Penilaian 6
4.2 Alasan Penilaian Power 6
4.3 Alasan Penilaian Interest 7
BAB V ANALISIS KATEGORI STAKEHOLDER MATRIX 9
5.1 Cara Menentukan Kategori 9
5.2 Hasil Penempatan 9
5.3 Visualisasi Power–Interest Grid 10
5.4 Uraian Tiap Kategori 11
BAB VI STRATEGI KOMUNIKASI TIAP KATEGORI 12
6.1 Strategi untuk Manage Closely 12
6.2 Strategi untuk Keep Satisfied 12
6.3 Strategi untuk Keep Informed 12
6.4 Strategi untuk Monitor 13
6.5 Ringkasan Strategi Komunikasi 13
BAB VII ANALISIS AKHIR: STAKEHOLDER MAP 14
7.1 Stakeholder Map di Excel 14
7.2 Hal yang Terbaca dari Peta 14
BAB VIII PENUTUP 15
8.1 Kesimpulan 15
8.2 Saran 15

DAFTAR PUSTAKA.....16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klinik Sehat Bersama sampai sekarang masih menjalankan sebagian pelayanannya dengan pencatatan manual, ditambah beberapa aplikasi yang jalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung. Dampaknya terasa sehari-hari: mencari riwayat pasien memakan waktu, antrean gampang menumpuk, dan laporan operasional harus disusun terpisah. Untuk mengatasi itu, manajemen berencana membangun Sistem Informasi Klinik Terintegrasi.

Proyek seperti ini tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis saja. Siapa yang terlibat, apa yang mereka harapkan, dan seberapa besar pengaruh mereka terhadap keputusan akan sangat menentukan apakah sistem nanti benar-benar dipakai atau justru ditinggalkan. Rajala dan Aaltonen (2020) mencatat bahwa kegagalan proyek sistem informasi sering berawal dari ekspektasi stakeholder yang tidak jelas atau tidak selaras dengan tujuan proyek. Karena itu, sebelum masuk ke elisitasi kebutuhan, para stakeholder perlu dikenali dan dipetakan lebih dulu.

Makalah ini mengikuti pola analisis pada studi kasus e-learning Universitas X yang ada di modul praktikum, lalu menerapkannya pada kasus Klinik Sehat Bersama.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

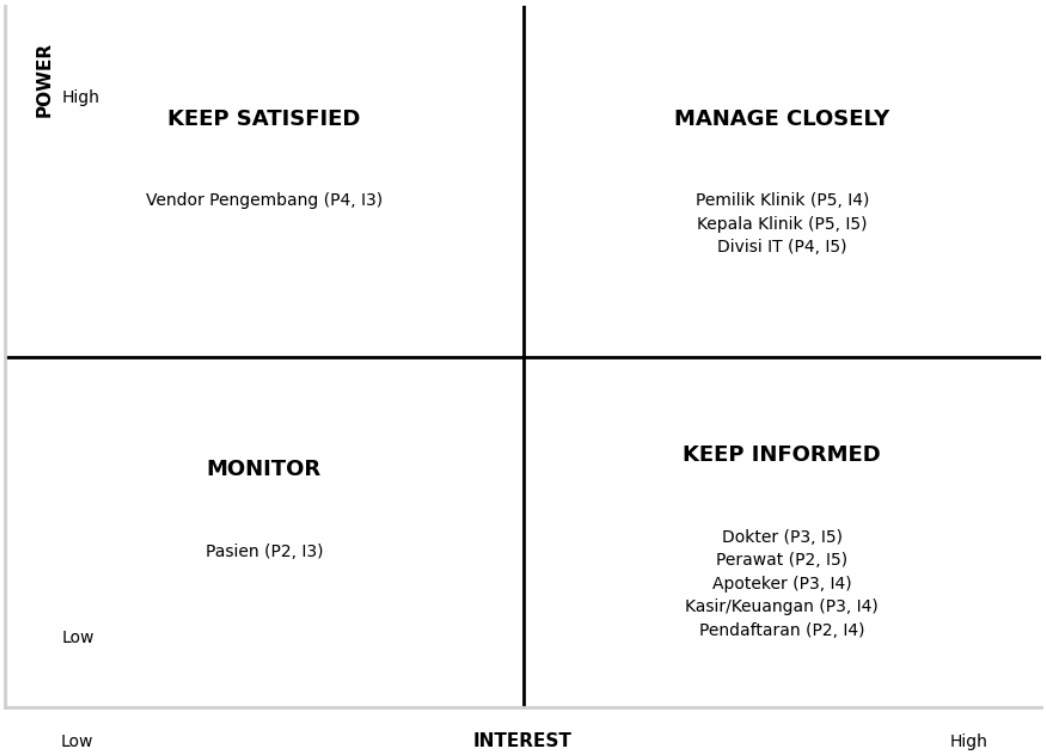
- Mengidentifikasi minimal delapan stakeholder yang terlibat dalam proyek beserta peran dan kepentingannya.
- Menilai tingkat Power dan Interest setiap stakeholder pada skala 1 sampai 5, lengkap dengan alasannya.
- Menempatkan stakeholder ke dalam Power–Interest Grid dan menentukan kategorinya.
- Menyusun strategi komunikasi untuk tiap kategori.
- Merangkum hasil akhir dalam Stakeholder Map di Excel.

1.3 Dasar Analisis

Analisis ini memakai Power–Interest Grid yang dikemukakan Boutilier (2024), yaitu pengelompokan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh (power) dan tingkat kepentingan (interest). Dari dua sumbu itu terbentuk empat kategori, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Empat Kategori Stakeholder pada Power–Interest Grid

Kategori	Power	Interest	Pendekatan
Manage Closely	Tinggi	Tinggi	Stakeholder utama, dilibatkan secara intensif
Keep Satisfied	Tinggi	Rendah	Stakeholder berpengaruh, dijaga kepuasannya
Keep Informed	Rendah	Tinggi	Stakeholder informatif, diajak berkomunikasi secara rutin
Monitor	Rendah	Rendah	Stakeholder minor, cukup dipantau



Penilaian memakai skala 1 sampai 5 seperti pada modul. Untuk Power, angka 1 berarti hampir tidak punya pengaruh dan angka 5 berarti penentu utama keberhasilan atau kegagalan proyek. Untuk Interest, angka 1 berarti hampir tidak peduli dan angka 5 berarti sangat peduli serta sangat bergantung pada hasil proyek. Nilai 4 dan 5 kami anggap tinggi, sedangkan nilai 1 sampai 3 kami anggap rendah.

BAB II PROFIL KASUS

2.1 Profil Singkat Organisasi

Klinik Sehat Bersama adalah klinik kesehatan swasta yang melayani pemeriksaan umum, konsultasi dokter, tindakan medis, dan pelayanan obat. Proyek pengembangan sistem dipimpin langsung oleh Kepala Klinik dan melibatkan beberapa pihak dari dalam maupun luar klinik.

2.2 Proses Kerja Utama

Dari uraian kasus, alur pelayanan di klinik kurang lebih berjalan seperti ini.

- Pasien mendaftar dan datanya dicatat oleh petugas pendaftaran.
- Pasien diperiksa oleh dokter dan perawat, kemudian tindakan serta kondisi pasien dicatat ke rekam medis.
- Dokter menulis resep, lalu apoteker menyiapkan obat dan memeriksa ketersediaan stok.
- Pasien membayar di kasir, dan transaksi dicatat untuk laporan keuangan.
- Manajemen menerima laporan operasional untuk pengambilan keputusan.

2.3 Masalah dan Rencana Sistem

Masalah utamanya ada pada pencatatan yang masih manual dan aplikasi yang belum terintegrasi. Akibatnya pelayanan kurang efisien, pencarian riwayat pasien lama, dan laporan disusun terpisah-pisah. Sistem yang direncanakan akan mencakup pendaftaran pasien, pengelolaan data pasien, rekam medis, pemeriksaan dokter, pencatatan tindakan, resep dan pengelolaan obat, pembayaran, serta laporan manajemen.

2.4 Kondisi dan Kendala Proyek

Ada tiga kondisi yang ikut memengaruhi cara kita menilai stakeholder.

- **Anggaran terbatas.** Tidak semua fitur bisa dikembangkan sekaligus, jadi prioritas fitur harus disepakati bersama.
- **Waktu sudah ditentukan.** Sistem harus bisa dipakai sesuai jadwal dari manajemen.
- **Data pasien bersifat sensitif.** Keamanan dan pembatasan akses data menjadi perhatian penting. Winch (2017) mengingatkan bahwa pengelolaan stakeholder juga mencakup aspek etika dan sosial, dan data pasien adalah contoh yang jelas.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa peralihan dari proses manual ke sistem terkomputerisasi akan membutuhkan waktu adaptasi dan pelatihan bagi tenaga klinik.

BAB III IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

3.1 Daftar Stakeholder, Peran, dan Kepentingan

Dari studi kasus kami menemukan sepuluh stakeholder, melebihi batas minimal delapan. Masing-masing punya peran dan harapan yang berbeda terhadap sistem.

Tabel 2. Daftar Stakeholder Proyek Sistem Informasi Klinik

No	Stakeholder	Peran dalam proyek	Kepentingan terhadap sistem
1	Pemilik Klinik	Pemilik usaha dan penyedia dana proyek	Kualitas pelayanan meningkat dan bisnis klinik bisa berkembang
2	Kepala Klinik	Pemimpin proyek	Proses pelayanan terintegrasi dan tersedia informasi untuk mengambil keputusan
3	Dokter	Pengguna utama untuk pemeriksaan dan rekam medis	Akses cepat ke riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan pasien
4	Perawat	Mencatat tindakan dan kondisi pasien	Sistem yang mudah dipakai saat mencatat
5	Petugas Pendaftaran	Mendaftarkan pasien dan mengelola data pasien	Pendaftaran lebih cepat sehingga antrean berkurang
6	Apoteker	Mengelola resep dan stok obat	Informasi resep akurat dan stok obat selalu diperbarui
7	Petugas Kasir/Keuangan	Mencatat pembayaran dan membuat laporan transaksi	Pencatatan pembayaran dan laporan transaksi yang akurat
8	Divisi IT	Implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan sistem	Sistem berjalan aman, terintegrasi, dan mudah dipelihara
9	Vendor Pengembang	Membangun dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan klinik	Pekerjaan selesai sesuai kebutuhan, jadwal, dan kontrak

No	Stakeholder	Peran dalam proyek	Kepentingan terhadap sistem
10	Pasien	Pengguna layanan klinik	Pendaftaran dan pelayanan lebih cepat, informasi lebih akurat

3.2 Informasi yang Perlu Digali dari Setiap Stakeholder

Identifikasi ini juga menjadi bekal untuk wawancara dan observasi di pertemuan berikutnya. Tabel berikut menunjukkan apa yang perlu ditanyakan ke masing-masing pihak.

Tabel 3. Informasi yang Perlu Diperoleh dari Stakeholder

Stakeholder	Informasi yang perlu digali
Pemilik Klinik	Target bisnis, batas anggaran, dan fitur yang paling diprioritaskan
Kepala Klinik	Alur pelayanan yang ingin diintegrasikan, jenis laporan yang dibutuhkan, dan tenggat penggunaan sistem
Dokter	Data apa saja yang perlu dilihat saat memeriksa, cara mencari riwayat pasien saat ini, dan kekhawatiran terhadap sistem baru
Perawat	Apa saja yang dicatat, kapan dan di mana pencatatan dilakukan, serta kendalanya
Petugas Pendaftaran	Langkah pendaftaran, data yang diminta dari pasien, dan penyebab antrean
Apoteker	Alur penerimaan resep, cara memantau stok, dan masalah ketidaksesuaian stok
Petugas Kasir/Keuangan	Jenis pembayaran, cara merekap transaksi, dan format laporan yang dibutuhkan
Divisi IT	Infrastruktur yang ada, aplikasi lama yang harus terhubung, kebutuhan keamanan, dan siapa yang memelihara
Vendor Pengembang	Kemampuan teknis, perkiraan waktu dan biaya, serta batas penyesuaian sistem
Pasien	Hambatan saat mendaftar dan menunggu, informasi yang diharapkan, dan kekhawatiran soal data pribadi

BAB IV PENILAIAN POWER DAN INTEREST

4.1 Hasil Penilaian

Nilai diberikan dengan menimbang dua hal: seberapa besar stakeholder bisa memengaruhi keputusan dan jalannya proyek (Power), serta seberapa besar hasil proyek akan memengaruhi dan dipedulikan oleh mereka (Interest).

Tabel 4. Nilai Power dan Interest Stakeholder

No	Stakeholder	Power	Interest	Posisi
1	Pemilik Klinik	5	4	Tinggi–Tinggi
2	Kepala Klinik	5	5	Tinggi–Tinggi
3	Dokter	4	5	Tinggi–Tinggi
4	Perawat	3	5	Rendah–Tinggi
5	Petugas Pendaftaran	2	5	Rendah–Tinggi
6	Apoteker	3	4	Rendah–Tinggi
7	Petugas Kasir/Keuangan	2	4	Rendah–Tinggi
8	Divisi IT	4	5	Tinggi–Tinggi
9	Vendor Pengembang	4	3	Tinggi–Rendah
10	Pasien	2	3	Rendah–Rendah

4.2 Alasan Penilaian Power

Tabel 5. Argumentasi Nilai Power

No	Stakeholder	Nilai	Alasan
1	Pemilik Klinik	5	Pemegang dana dan arah bisnis. Pemilik bisa menyetujui, menunda, atau menghentikan proyek.
2	Kepala Klinik	5	Memimpin proyek dan memutuskan prioritas serta cakupan integrasi sistem.
3	Dokter	4	Tenaga inti pelayanan. Kalau dokter tidak mau mengisi atau memakai rekam medis elektronik, sistem tidak akan berguna. Namun dokter bukan pengambil keputusan anggaran, jadi tidak diberi 5.

No	Stakeholder	Nilai	Alasan
4	Perawat	3	Bisa memengaruhi kualitas data tindakan dan kondisi pasien, tetapi bukan penentu keputusan proyek.
5	Petugas Pendaftaran	2	Pengguna operasional. Masukannya penting saat uji coba, tetapi tidak ikut memutuskan arah proyek.
6	Apoteker	3	Akurasi resep dan stok obat berkaitan dengan keselamatan pasien sehingga usulannya diperhitungkan, tetapi bukan penentu proyek.
7	Petugas Kasir/Keuangan	2	Kebutuhannya relatif jelas (mencatat pembayaran dan membuat laporan). Ia tidak memegang anggaran proyek.
8	Divisi IT	4	Memegang keputusan teknis penting: implementasi, keamanan data, dan integrasi dengan aplikasi lama.
9	Vendor Pengembang	4	Memegang kendali teknis pembangunan sistem. Kualitas dan ketepatan jadwal sangat bergantung padanya.
10	Pasien	2	Tidak ikut memutuskan, tetapi keluhan dan tingkat kepuasan pasien bisa memengaruhi reputasi klinik secara tidak langsung.

4.3 Alasan Penilaian Interest

Tabel 6. Argumentasi Nilai Interest

No	Stakeholder	Nilai	Alasan
1	Pemilik Klinik	4	Peduli karena hasilnya menyangkut kualitas layanan dan bisnis, tetapi tidak mengurusi detail harian proyek.
2	Kepala Klinik	5	Sebagai pemimpin proyek, keberhasilan sistem adalah tanggung jawab langsungnya.
3	Dokter	5	Pekerjaan sehari-hari dokter akan bergantung langsung pada sistem, terutama akses riwayat pasien.

No	Stakeholder	Nilai	Alasan
4	Perawat	5	Setiap pencatatan tindakan akan lewat sistem, sehingga cara kerja mereka ikut berubah.
5	Petugas Pendaftaran	5	Titik pertama yang bersentuhan dengan sistem dan paling merasakan dampaknya pada antrean.
6	Apoteker	4	Bergantung pada informasi resep dan stok, tetapi sebagian pekerjaan (menyiapkan obat) tetap dilakukan di luar sistem.
7	Petugas Kasir/Keuangan	4	Sistem langsung memengaruhi pencatatan dan laporan transaksi, meski cakupan kerjanya lebih sempit.
8	Divisi IT	5	Bertanggung jawab atas implementasi, keamanan, dan pemeliharaan, termasuk setelah proyek selesai.
9	Vendor Pengembang	3	Peduli pada penyelesaian proyek dan kontrak, tetapi dampak jangka panjangnya tidak sebesar bagi pihak klinik.
10	Pasien	3	Merasakan hasilnya (pelayanan lebih cepat), tetapi tidak bergantung pada sistem di balik layar dan tidak terlibat langsung dalam proyek.

BAB V ANALISIS KATEGORI STAKEHOLDER MATRIX

5.1 Cara Menentukan Kategori

Setelah nilai Power dan Interest didapat, setiap stakeholder ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kuadran. Aturannya sederhana: nilai 4 atau 5 dihitung tinggi, nilai 1 sampai 3 dihitung rendah. Dengan begitu garis pembatas antar kuadran berada di antara angka 3 dan 4, atau di titik 3,5. Cara ini sejalan dengan contoh e-learning, ketika Dosen (Power 3, Interest 4) masuk ke kelompok Power rendah dan Interest tinggi.

5.2 Hasil Penempatan

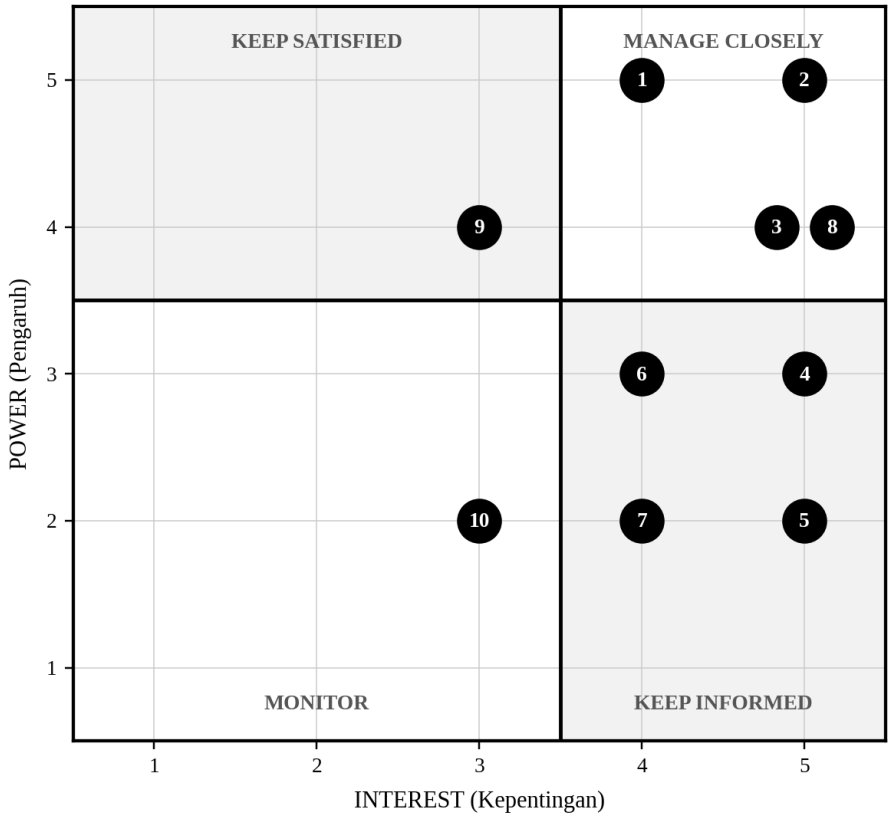
Tabel 7. Kategori Setiap Stakeholder pada Power–Interest Grid

No	Stakeholder	Power	Interest	Kategori	Alasan penempatan
1	Pemilik Klinik	5	4	Manage Closely	Penentu dana dan arah, hasil proyek menyangkut bisnisnya
2	Kepala Klinik	5	5	Manage Closely	Pemimpin proyek dengan keterlibatan paling besar
3	Dokter	4	5	Manage Closely	Penentu adopsi sistem di sisi medis
4	Perawat	3	5	Keep Informed	Sangat terdampak, tetapi bukan penentu keputusan
5	Petugas Pendaftaran	2	5	Keep Informed	Pengguna harian dengan kendali keputusan rendah
6	Apoteker	3	4	Keep Informed	Butuh data resep dan stok, pengaruh sedang
7	Petugas Kasir/Keuangan	2	4	Keep Informed	Terdampak langsung, pengaruh pada proyek kecil
8	Divisi IT	4	5	Manage Closely	Pelaksana teknis yang sangat peduli hasil

No	Stakeholder	Power	Interest	Kategori	Alasan penempatan
9	Vendor Pengembang	4	3	Keep Satisfied	Pegang kendali teknis, kepentingan jangka panjang terbatas
10	Pasien	2	3	Monitor	Merasakan hasil, tetapi tidak terlibat dan tidak bergantung pada sistem

5.3 Visualisasi Power–Interest Grid

Hasil penempatan di atas digambarkan pada grid berikut. Angka di dalam lingkaran sesuai dengan nomor stakeholder pada Tabel 7. Dokter (3) dan Divisi IT (8) punya nilai yang sama sehingga titiknya digeser sedikit agar tidak bertumpuk.



1. Pemilik Klinik
2. Kepala Klinik
3. Dokter
4. Perawat
5. Petugas Pendaftaran
6. Apoteker
7. Petugas Kasir/Keuangan
8. Divisi IT
9. Vendor Pengembang
10. Pasien

Gambar 1. Power–Interest Grid Sistem Informasi Klinik Sehat Bersama

5.4 Uraian Tiap Kategori

a. Dikelola secara dekat (Manage Closely)

Empat stakeholder masuk kelompok ini: Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Dokter, dan Divisi IT. Mereka punya pengaruh besar sekaligus sangat berkepentingan. Pemilik dan Kepala Klinik menentukan arah, anggaran, dan prioritas. Dokter menentukan apakah sistem dipakai dalam praktik. Divisi IT

memastikan sistemnya sendiri berjalan aman dan terintegrasi. Kalau salah satu dari mereka kurang sejalan, dampaknya langsung terasa pada proyek.

b. Dijaga kepuasannya (Keep Satisfied)

Satu stakeholder berada di sini, yaitu Vendor Pengembang. Vendor memegang kendali teknis tetapi kepentingannya terbatas pada penyelesaian proyek dan kontrak. Yang perlu dijaga adalah hubungan kerja dan kepastian jadwal, karena keterlambatan di pihak vendor akan langsung mengganggu target waktu yang sudah ditetapkan manajemen.

c. Dilibatkan melalui komunikasi rutin (Keep Informed)

Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, dan Petugas Kasir/Keuangan masuk kelompok ini. Mereka adalah pengguna harian yang kepentingannya tinggi, tetapi tidak ikut memutuskan arah proyek. Perawat dan Apoteker berada di batas atas kelompok ini karena nilai Power-nya 3. Suara mereka tetap perlu didengar, sebab kebiasaan kerja merekalah yang akan berubah paling banyak.

d. Cukup dimonitor (Monitor)

Pasien berada di kuadran ini. Pasien adalah penerima manfaat akhir, tetapi mereka tidak terlibat dalam proyek dan tidak bergantung pada sistem di balik layar. Meski begitu, posisi ini bukan berarti pasien boleh diabaikan. Mereka cukup dipantau lewat survei kepuasan dan keluhan, tanpa perlu dilibatkan dalam rapat proyek.

BAB VI STRATEGI KOMUNIKASI TIAP KATEGORI

Strategi komunikasi disusun berdasarkan posisi stakeholder pada grid. Prinsipnya, makin tinggi pengaruh dan kepentingan seorang stakeholder, makin sering dan makin dua arah komunikasi yang dilakukan. Penanggung jawab komunikasi secara umum adalah Kepala Klinik selaku pemimpin proyek, dibantu Divisi IT untuk hal teknis.

6.1 Strategi untuk Manage Closely

Kategori ini berisi Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Dokter, dan Divisi IT. Tujuannya adalah membuat mereka ikut memutuskan, bukan sekadar diberi tahu. Komunikasi dilakukan dua arah dan sering.

- **Pemilik dan Kepala Klinik.** Rapat pengarah dua mingguan dengan laporan satu halaman berisi progres, penggunaan anggaran, dan risiko. Karena anggaran terbatas, keputusan prioritas fitur diambil bersama dalam rapat ini. Contoh: apakah modul laporan manajemen dibangun di tahap pertama atau menyusul setelah rekam medis selesai.
- **Dokter.** Lokakarya kebutuhan dan demo prototipe tampilan rekam medis, dijadwalkan di luar jam praktik agar tidak mengganggu pasien. Tunjuk satu atau dua dokter sebagai perwakilan yang menjadi rujukan teman-temannya.
- **Divisi IT.** Koordinasi singkat setiap hari kerja (sekitar 15 menit) serta dokumen teknis bersama tentang hak akses, pencadangan data, dan integrasi dengan aplikasi lama.

6.2 Strategi untuk Keep Satisfied

Kategori ini hanya berisi Vendor Pengembang. Tujuannya menjaga vendor tetap puas dan bekerja sesuai rencana. Kontrak dilengkapi perjanjian tingkat layanan (SLA) dan jadwal milestone yang jelas. Progres dibahas dalam rapat mingguan atau dua mingguan. Kebutuhan klinik diberikan secara tertulis supaya tidak ada salah paham, dan setiap permintaan perubahan lewat formulir perubahan. Contoh: bila dokter meminta tambahan kolom di rekam medis, permintaan itu dicatat, dinilai dampak biaya dan waktunya, lalu disetujui Kepala Klinik sebelum dikerjakan. Dengan cara ini anggaran yang terbatas tidak membengkak diam-diam. Pembayaran sesuai termin juga ikut menjaga kepuasan vendor.

6.3 Strategi untuk Keep Informed

Kategori ini berisi Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, dan Petugas Kasir/Keuangan. Tujuannya membuat mereka siap dan merasa didengar. Karena mereka pengguna harian, komunikasi berfokus pada pelatihan dan masukan.

- Pelatihan sesuai peran sebelum sistem dipakai. Petugas pendaftaran dilatih alur daftar pasien baru dan lama, apoteker dilatih alur resep dan stok, kasir dilatih pencatatan pembayaran dan laporan.
- Sesi uji coba dengan skenario nyata. Contoh: petugas pendaftaran mencoba mendaftarkan 10 pasien secara berurutan untuk melihat apakah antrean memang lebih cepat.
- Kabar progres singkat tiap dua minggu lewat grup kerja atau papan pengumuman, ditambah satu kanal tanya jawab.
- Pendampingan di lokasi selama minggu pertama sistem dipakai, mengingat adanya kekhawatiran soal waktu adaptasi.

6.4 Strategi untuk Monitor

Kategori ini berisi Pasien. Tujuannya memantau tanpa membebani. Klinik cukup menyediakan survei kepuasan singkat, misalnya tiga pertanyaan setelah berobat tentang kecepatan pendaftaran, lama menunggu, dan kejelasan informasi. Perubahan layanan diumumkan lewat papan pengumuman atau poster, misalnya "Pendaftaran kini lebih cepat". Klinik juga perlu menyampaikan bahwa data pasien dikelola dengan aman. Hasil survei dibaca Kepala Klinik secara berkala, dan bila keluhan meningkat, pasien dapat dinaikkan ke kategori yang lebih aktif.

6.5 Ringkasan Strategi Komunikasi

Tabel 8. Ringkasan Strategi Komunikasi

Kategori	Stakeholder	Bentuk komunikasi	Frekuensi
Manage Closely	Pemilik, Kepala Klinik, Dokter, Divisi IT	Rapat pengarah, lokakarya dan demo, koordinasi teknis, keputusan bersama	Dua mingguan; harian untuk IT
Keep Satisfied	Vendor Pengembang	Kontrak dan SLA, rapat progres, formulir perubahan	Mingguan atau dua mingguan
Keep Informed	Perawat, Pendaftaran, Apoteker, Kasir/Keuangan	Pelatihan, uji coba, kabar progres, kanal tanya jawab	Dua mingguan; pendampingan saat peluncuran
Monitor	Pasien	Survei kepuasan, pengumuman layanan, kotak saran	Berkala (bulanan)

BAB VII ANALISIS AKHIR: STAKEHOLDER MAP

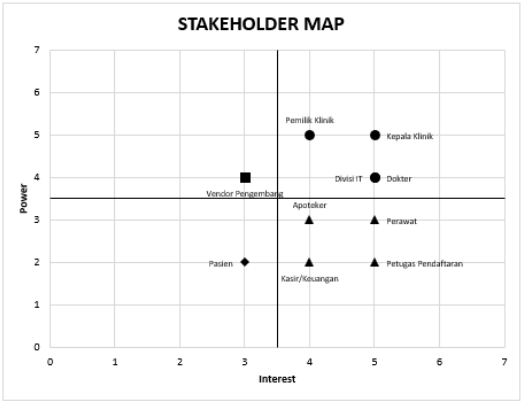
7.1 Stakeholder Map di Excel

Seluruh hasil analisis dirangkum dalam file Excel dengan nama sheet Stakeholder Map, mengikuti contoh e-learning pada modul. Sheet ini memuat daftar stakeholder beserta nilai Power dan Interest, baris Chart Axis sebagai batas tinggi dan rendah, dan grafik sebaran. Kolom kategori terisi otomatis dari nilai tersebut, jadi bila nilai diubah, kategorinya ikut berubah.

STAKEHOLDER MAP

PROJECT NAME: KLINIK **SISTEM INFORMASI KLINIK (Klinik Sehat Bersama)**

No	Stakeholder	Power	Interest	Kategori
1	Pemilik Klinik	5	4	Kelola secara dekat
2	Kepala Klinik	5	5	Kelola secara dekat
3	Dokter	4	5	Kelola secara dekat
4	Perawat	3	5	Komunikasi rutin
5	Petugas Pendaftaran	2	5	Komunikasi rutin
6	Apoteker	3	4	Komunikasi rutin
7	Kasir/Keuangan	2	4	Komunikasi rutin
8	Divisi IT	4	5	Kelola secara dekat
9	Vendor Pengembang	4	3	Jaga kepuasan
10	Pasien	2	3	Monitor
	Chart Axis (batas tinggi/rendah)	3,5	3,5	



Gambar 2. Stakeholder Map Sistem Informasi Klinik

Satu catatan kecil: pada contoh e-learning sumbu horizontalnya adalah Power, sedangkan di sini kami memakai Interest di sumbu horizontal dan Power di sumbu vertikal. Pilihan ini mengikuti langkah di modul dan Gambar 5.1 pada Boutilier (2024).

7.2 Hal yang Terbaca dari Peta

Dari peta tersebut tampak bahwa sebagian besar stakeholder (delapan dari sepuluh) berada di sisi Interest tinggi. Artinya proyek ini akan sangat terasa bagi orang dalam klinik, sehingga dukungan dan kesiapan mereka menentukan hasil. Empat stakeholder berada di kuadran Manage Closely, dan di sanalah energi komunikasi sebaiknya dipusatkan.

Ada beberapa titik rawan yang perlu diwaspadai sejak awal. Pertama, adopsi oleh dokter, karena Power dan Interest-nya tinggi sementara waktu mereka paling terbatas. Kedua, anggaran yang terbatas bisa memicu perbedaan prioritas antara pemilik, kepala klinik, dan pengguna. Ketiga, keamanan data pasien yang berada di tangan Divisi IT dan vendor, sehingga hak akses dan kesepakatan kerja perlu ditulis dengan jelas. Keempat, kesiapan perawat, petugas pendaftaran, dan apoteker yang

belum tentu terbiasa dengan sistem baru. Tepeli (2021) menekankan bahwa risiko yang bersumber dari stakeholder sebaiknya dianalisis sejak tahap awal, lalu dituangkan dalam project charter bersama strategi komunikasinya.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Proyek Sistem Informasi Klinik Terintegrasi di Klinik Sehat Bersama melibatkan sepuluh stakeholder: Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Dokter, Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Petugas Kasir/Keuangan, Divisi IT, Vendor Pengembang, dan Pasien. Berdasarkan nilai Power dan Interest, empat stakeholder masuk Manage Closely (Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Dokter, Divisi IT), satu masuk Keep Satisfied (Vendor), empat masuk Keep Informed (Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Kasir/Keuangan), dan satu masuk Monitor (Pasien).

Setiap kategori punya strategi komunikasi yang berbeda, mulai dari rapat pengarah dan keputusan bersama, pengelolaan kontrak dengan vendor, pelatihan dan uji coba bagi pengguna harian, sampai survei kepuasan bagi pasien.

8.2 Saran

Hasil pemetaan ini sebaiknya dijadikan dasar saat menyusun project charter dan menjadwalkan wawancara pada pertemuan berikutnya. Penilaian Power dan Interest juga perlu ditinjau ulang secara berkala, karena posisi stakeholder bisa berubah seiring berjalannya proyek. Misalnya pasien dapat naik ke kategori yang lebih aktif bila keluhan terhadap pelayanan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Boutilier. (2024). Dikutip dalam Modul Praktikum Pertemuan 1: Identifikasi Stakeholder dan Konteks Organisasi.

Rajala dan Aaltonen. (2020). Dikutip dalam Modul Praktikum Pertemuan 1: Identifikasi Stakeholder dan Konteks Organisasi.

Tepeli. (2021). Dikutip dalam Modul Praktikum Pertemuan 1: Identifikasi Stakeholder dan Konteks Organisasi.

Winch. (2017). Dikutip dalam Modul Praktikum Pertemuan 1: Identifikasi Stakeholder dan Konteks Organisasi.

Modul Praktikum Pertemuan 1. (t.t.). *Identifikasi Stakeholder dan Konteks Organisasi*. Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi Garut.